

TRAUMATISMOS DENTOALVEOLARES

Gema Arenas de Frutos, Elena Salomé Bullejos Martínez, Samuel Espías Alonso, Pablo Montes Fernández-Micheltorena, Eduardo Monteserín Martínez, Marta Peña Barreno, Raúl Antúnez-Conde

INTRODUCCIÓN

Los traumatismos dentoalveolares constituyen un motivo frecuente de valoración en urgencias, sobre todo en la edad pediátrica. Precisan habitualmente la evaluación de un dentista, aunque el manejo médico temprano de los mismos resulta ventajoso en cuanto a pronóstico de estas lesiones.

Las lesiones dentoalveolares pueden clasificarse:

- Fracturas **dentales: simples**, que afectan a la corona del diente (con o sin exposición pulpar (complicadas/no complicadas) o **complejas**, que afectan a la raíz del diente.
- Fracturas de **estructuras de soporte periodontales**: concusión (traumatismo sin movilidad), subluxación (movilidad sin desplazamiento), luxaciones (movilidad con desplazamiento: intrusivas, extrusivas y laterales) y avulsión (salida del diente del alvéolo)
- Lesiones de **hueso de soporte**: conminución, fracturas de pared alveolar o del proceso alveolar.
- Lesiones de **partes blandas**: contusión, abrasión, laceración.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de estas lesiones será principalmente clínico y exploratorio, mediante inspección visual y táctil. Las pruebas de imagen habitualmente se diferirán para su indicación por parte del especialista (odontólogo / cirujano maxilofacial), siendo de vital importancia la ortopantomografía y las radiografías simples periapicales.

Deberá realizarse estudio complementario mediante tomografía computarizada en casos de sospecha de fractura alveolar o maxilar/mandibular asociada.

Manejo/tratamiento en urgencias

CONCUSIÓN / SUBLUXACIÓN / FRACTURAS DENTALES	Analgesia, antibioterapia (salvo fractura simples), dieta blanda, enjuagues con clorhexidina y atención temprana (2-3 días) por su dentista
LUXACIÓN	Analgesia, antibioterapia, dieta blanda, enjuagues con clorhexidina y atención preferente (cuanto antes) por su dentista
AVULSIÓN	Dentición temporal: NO REPONER. Hemostasia. Mismas medidas de tratamiento y evaluación preferente por su dentista Dentición definitiva: • Reposición inmediata (antes de 1 hora): lavado del diente con suero fisiológico y reimplantación. Sujeción digital o con gasa e inmovilización mediante sutura. Atención urgente por dentista para ferulización definitiva • Si no es posible: transporte adecuado de pieza (suero fisiológico, leche, saliva) y atención urgente por dentista
FRACTURAS DENTOALVEOLARES	Valorar grado de movilidad (si severa, precisa atención urgente por CMF/dentista para ferulización). Analgesia, antibioterapia, dieta blanda, enjuagues con clorhexidina y atención urgente/preferente por su dentista
LESIONES DE TEJIDOS BLANDOS	Limpieza con suero fisiológico y clorhexidina. Hemostasia. Sutura en caso de heridas complejas. Analgesia, antibioterapia, enjuagues con clorhexidina y control diferido (dentista/CMF)

BIBLIOGRAFÍA

- Cirugía Oral y Maxilofacial. Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial. 3ª Edición.
- Tratado de Cirugía Oral y Maxilofacial. C. Navarro Vila.